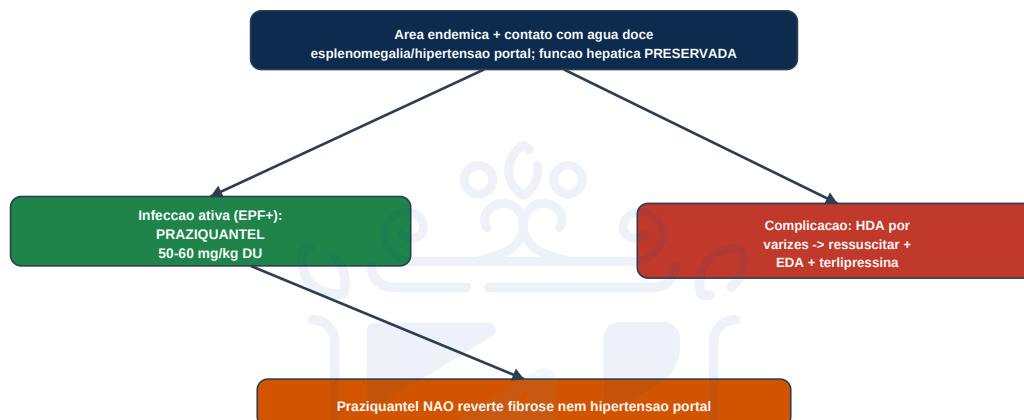


ESQUISTOSSOMOSE — HP + PRAZIQUANTEL

FLUXOGRAMA — ABORDAGEM

ESQUISTO — FORMA HEPATOESPLÊNICA NO PS



DEFINIÇÃO E FORMAS CLÍNICAS

S. MANSONI

- Parasitose crônica por *Schistosoma mansoni* (Brasil); contato com água doce contendo caramujos *Biomphalaria*; o verme adulto vive nos vasos mesentéricos e os ovos causam fibrose hepática/intestinal
- Causa mais comum de HIPERTENSÃO PORTAL NÃO CIRRÓTICA no Brasil — função hepática PRESERVADA (diferente da cirrose)
- Assintomática (50-60%); AGUDA (febre de Katayama, 3-8 sem pós-exposição: febre, urticária, tosse, diarreia, eosinofilia > 30%)
- Intestinal (diarreia com muco/sangue); hepatointestinal; HEPATOESPLÊNICA (5-10%, mais grave): esplenomegalia volumosa + hipertensão portal (varizes/ascite)
- Ectópicas (raras): NEUROesquistossomose (mielite), pulmonar, glomerulonefrite

CLASSIFICAÇÃO DA FORMA HEPATOESPLÊNICA

Grupo	Características
A — Compensada	Hepatoesplenomegalia, sem hipertensão portal clínica, função preservada, varizes ausentes/pequenas
B — HP compensada	Esplenomegalia volumosa + varizes (médio/grosso calibre), sem sangramento prévio, sem ascite
C — Descompensada	História de hemorragia digestiva, ascite, encefalopatia (rara - sugere coinfeção/cirrose)

RED FLAGS

EMERGÊNCIAS

- HEMORRAGIA digestiva alta por VARIZES esofágicas (hematêmese/melena) — pode ser maciça, com choque
- Esplenomegalia volumosa (Schuffner IV-V) — risco de ruptura; ascite tensa
- Anemia grave ($Hb < 7$) e plaquetopenia (< 50.000) por HIPERESPLENISMO
- NEUROesquistossomose: déficit motor, paraplegia, alteração esfíncteriana (emergência neurológica)
- ATENÇÃO: icterícia/encefalopatia importante sugere COINFECÇÃO (HBV/HCV/álcool), pois a função hepática costuma estar preservada

DIAGNÓSTICO

EPF + IMAGEM

- EPF (Kato-Katz): padrão-ouro — ovos de *S. mansoni*; 3 amostras em dias alternados; quantifica a carga (OPG)
- Biópsia retal se EPF negativo com alta suspeita; PCR de fezes (mais sensível)
- Sorologia (ELISA): útil na fase aguda (Katayama) quando EPF negativo; NÃO diferencia ativa de passada
- Labs: anemia/leucopenia/PLAQUETOPENIA (hiperesplenismo), eosinofilia; função hepática PRESERVADA (albumina/bilirrubina normais)
- USG abdome: fibrose PERIPORTAL ('dedos de luva'), esplenomegalia, veia porta > 13 mm, ascite; ENDOSCOPIA para rastrear varizes (todos os hepatoesplênicos)

TRATAMENTO — ESPECÍFICO E DAS COMPLICAÇÕES

Rx PRAZIQUANTEL + MANEJO DA HP

PRAZIQUANTEL 50-60 mg/kg VO em dose única (após refeição; dividir em 2 tomadas com 4-6h se > 60 kg) — todas as formas com EPF+; eficácia 80-90%; controle de cura (EPF) em 6 meses

Praziquantel NÃO reverte a fibrose nem trata a hipertensão portal (sequela); objetivo: eliminar o parasita e prevenir progressão/reinfecção

HDA por varizes: 2 acessos + cristalóide + transfusão (alvo Hb 7-9); TERLIPRESSINA 2 mg EV 4/4h (ou octreotíde); IBP EV;

CEFTRIAXONA 1 g/dia (profilaxia); EDA urgente (< 12 h) com LIGADURA elástica; balão/TIPS se refratário

Profilaxia de sangramento (varizes médio/grosso): Propranolol 40-80 mg 12/12h (FC-alvo 55-60) ou ligadura elástica

Ascite: dieta hipossódica + Espironolactona $\pm$ Furosemida; paracentese (+ albumina se > 5 L)

NEUROesquistossomose: Prednisona 1-1,5 mg/kg/dia ANTES do praziquantel (4-6 sem); RM medular urgente; neurocirurgia se compressão

INTERNAÇÃO, ALTA E SEGUIMENTO

DECISÃO

- ☐ INTERNAR: hemorragia digestiva, ascite tensa, anemia grave sintomática, neuroesquistossomose, abdome agudo, Katayama grave, necessidade de esplenectomia
- ☐ ALTA: estável, sem sangramento ativo, Hb estável, ascite controlada, praziquantel feito/prescrito, seguimento garantido
- ☐ Hiperesplenismo refratário + citopenias graves: esplenectomia (vacinar antes — pneumococo, meningococo, Hib)
- ☐ Prevenção: evitar contato com água doce em área endêmica; tratar familiares/comunicantes; notificação compulsória (SINAN)
- ☐ Seguimento: EPF de controle em 6 meses, endoscopia anual (se varizes), USG anual; infectologia/hepatologia

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Paciente com esquistossomose hepatoesplênica (grupo ____); procedência endêmica; contato com água doce ____; praziquantel prévio ____.
- Complicação atual: HDA por varizes ____ / ascite ____ / neuroesquistossomose ____; Hb ____, plaquetas ____ (hiperesplenismo); função hepática preservada ____.
- USG: esplenomegalia ____, fibrose periportal ____, veia porta ____ mm; EDA: varizes ____.
- Conduta: ressuscitação ____, terlipressina ____, EDA/ligadura ____, praziquantel ____; solicito internação enfermaria/UTI para controle de HDA/HP.

SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Qual é a principal causa de hipertensão portal NÃO cirrótica no Brasil?

- A) Cirrose alcoólica
- B) Esquistossomose mansônica (forma hepatoesplênica)
- C) Trombose de veia porta isolada
- D) Hepatite autoimune
- E) Síndrome de Budd-Chiari

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual achado diferencia a esquistossomose hepatoesplênica da cirrose?

- A) Esplenomegalia
- B) Função hepática PRESERVADA (albumina e bilirrubinas normais)
- C) Presença de varizes
- D) Ascite
- E) Hipertensão portal

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Qual é o tratamento específico da esquistossomose com infecção ativa?

- A) Albendazol
- B) Praziquantel 50-60 mg/kg VO em dose única
- C) Ivermectina
- D) Metronidazol
- E) Mebendazol

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Sobre o praziquantel na esquistossomose hepatoesplênica, é correto:

- A) Reverte a fibrose periportal estabelecida
- B) Elimina o parasita, mas NÃO reverte a fibrose nem trata a hipertensão portal (sequela)
- C) Trata as varizes esofágicas
- D) É contraindicado em todas as formas
- E) Substitui a endoscopia

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Na neuroesquistossomose, qual conduta deve preceder o praziquantel?

- A) Antibiótico
- B) Corticoide (prednisona), para prevenir a reação inflamatória à morte dos parasitas
- C) Anticoagulação
- D) Diurético
- E) Nenhuma

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

A esquistossomose mansônica (forma hepatoesplênica) é a principal causa de hipertensão portal não cirrótica no Brasil, por fibrose periportal.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

A função hepática preservada (albumina e bilirrubinas normais) diferencia a esquistossomose da cirrose; icterícia/encefalopatia importantes sugerem coinfeção.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

O praziquantel 50-60 mg/kg VO em dose única é o tratamento específico para todas as formas com infecção ativa (EPF+).

QUESTÃO 4 → Resposta: B

O praziquantel elimina o parasita e previne progressão/reinfecção, mas não reverte a fibrose nem trata a hipertensão portal, que são sequelas — estas exigem manejo próprio (betabloqueador, ligadura).

QUESTÃO 5 → Resposta: B

Na neuroesquistossomose, inicia-se corticoide (prednisona) ANTES do praziquantel para prevenir a reação inflamatória à morte dos parasitas no SNC.

SM24
Suporte ao Plantão Médico